Akute bakterielle Sinusitis Dr Ömer Mit Dr Hatip 03.04.2026

Vollständige Anamnese

Patientin: Christine Müller
Alter: 64 Jahre
Geburtsdatum: 23.04.1962
Größe: 158 cm
Gewicht: ca. 65 kg

Aktuelle Beschwerden

Die 64-jährige Patientin stellt sich wegen seit **3 Wochen bestehender linksseitiger Gesichts- und Kopfschmerzen** vor. Die Beschwerden hätten **schleichend begonnen** und sich im Verlauf zunehmend verschlechtert, insbesondere seit etwa **1 Woche**.

Die Schmerzen seien **linksseitig unter dem Auge über der Wange** lokalisiert. Zusätzlich bestehe ein **Druckgefühl im Bereich des linken Auges** mit Ausstrahlung nach kranial bis zum Kopf sowie nach dorsal bis in den Nacken/Hinterkopf. Außerdem berichtet die Patientin über eine **behinderte Nasenatmung auf der linken Seite**.

Seit etwa einer Woche seien die Schmerzen **dauerhaft vorhanden**, zuvor seien sie eher intermittierend aufgetreten. Die Patientin beschreibt die Schmerzen als **drückend**. Die Schmerzintensität liege aktuell bei etwa **7/10**, zuvor zwischen **5 und 7/10**.

Zusätzlich habe sie das Gefühl einer **Schwellung im linken Gesicht**, insbesondere im Bereich der **Wange unter dem Auge**. Beim Blick in den Spiegel falle ihr eine Seitendifferenz auf. Das Berühren der betroffenen Stelle sei ebenfalls schmerzhaft. Eine leichte **Lichtempfindlichkeit** wird angedeutet. Außerdem berichtet sie, dass sie auf der linken Seite möglicherweise etwas schlechter sehe bzw. dass der Druck auf das Auge zunehme.

Die Patientin habe initial an eine **leichte Erkältung** gedacht. Eine eindeutige Besserung oder Verschlechterung durch bestimmte Faktoren könne sie nicht nennen. Analgetika hätten nur **kurzfristig**, für etwa eine Stunde, geholfen.

Bisherige Medikation gegen die Beschwerden

Die Patientin nahm bereits:

- **Paracetamol**
- **Ibuprofen**
- **Novalgin**

Darunter sei keine wesentliche Besserung eingetreten.

Begleitsymptome

Verneint werden:

- Fieber
- Schüttelfrost
- Nachtschweiß
- Schwindel
- Synkope
- Atemnot
- Husten
- Herzrasen / Herzklopfen

- Übelkeit
- Erbrechen
- Gewichtsverlust
- Beschwerden beim Wasserlassen
- Beschwerden beim Stuhlgang
- Hautveränderungen oder Verletzungen im Gesichtsbereich
- offene Wunden oder Bläschen im Gesicht

Vorhanden sind:

- Schlafstörungen aufgrund der Schmerzen, besonders seit 1 Woche
- verminderter Appetit in letzter Zeit
- subjektive Schwellung der linken Gesichtshälfte
- Schmerzen bei Berührung der betroffenen Seite

Frühere ähnliche Beschwerden / HNO-Vorgeschichte

Die Patientin berichtet, schon seit vielen Jahren Probleme mit der Nase zu haben. Ein HNO-Arzt habe früher geäußert, dass sie **Polypen auf der linken Seite** habe und eine **Operation** empfohlen. Diese sei bislang nicht erfolgt, da die Patientin Angst vor dem Eingriff gehabt habe.

Vorbehandlung

Die Patientin war bereits beim Hausarzt. Dort sei die Diagnose eines **Virusinfekts** gestellt worden. Sie habe **Schleimlöser** und **Nasenspray** erhalten. Eine Besserung sei jedoch nicht eingetreten.

Vegetative Anamnese

- Schlaf: derzeit deutlich gestört wegen Schmerzen
- Appetit: zuletzt vermindert
- Miktion: unauffällig
- Stuhlgang: unauffällig

Vorerkrankungen

- **Arterielle Hypertonie** seit ca. 6 Jahren
- **Schilddrüsenknoten / Schilddrüsenerkrankung** seit vielen Jahren

Operationen

- Operation am **linken Eierstock** bei Zyste, vor ca. 25 Jahren

Medikamentenanamnese

- **Candesartan** morgens und abends, genaue Dosierung unbekannt
- **L-Thyroxin** 50 µg 1-0-0
- zusätzlich zuletzt Paracetamol, Ibuprofen und Novalgin gegen die aktuellen Schmerzen

Allergien / Unverträglichkeiten

- **Penicillinallergie** mit Ganzkörperausschlag, damals Krankenhausbehandlung
- **Pollenallergie** mit laufender Nase, brennenden Augen und Luftnot über mehrere Monate
- Reaktion auf **Vitamin-C-Infusion** mit Luftnot, Herzrasen und Hautausschlag

Suchtanamnese

- **Nikotin:** seit 10 Jahren Nichtraucherin; zuvor etwa 25 Jahre lang geraucht, meist etwa 1/2 Schachtel täglich, phasenweise bis 1 Schachtel täglich
- **Alkohol:** selten, gelegentlich auf Feiern, eher Wein
- **Drogen:** verneint

Sozialanamnese

- Geschieden
- Lebt allein
- Ein Sohn
- Seit kurzem Rentnerin
- Früher beruflich in einer Firma in der Bauleitung tätig

Familienanamnese

- Mutter: **Diabetes mellitus Typ 2**, verstorben im Alter von 79 Jahren
- Vater: verstorben im Alter von 83 Jahren an **Herzinfarkt**
- Eine Schwester, nach Angaben der Patientin gesund

Gynäkologische Anamnese

- Seit über 15 Jahren postmenopausal
- Regelmäßige frauenärztliche Kontrollen etwa alle 2 Jahre
- Keine aktuellen gynäkologischen Beschwerden angegeben

Reiseanamnese

- Keine Auslandsreise in letzter Zeit

Impfstatus

- Nach eigener Angabe vollständig geimpft

🩺 Verdachtsdiagnose (VD)

Akute bakterielle Sinusitis (links), evtl. kompliziert

- wahrscheinlich **maxillaris / ethmoidalis**
- auf dem Boden einer **chronischen Rhinosinusitis mit Nasenpolypen**

Begründung:

- einseitige (links) Schmerzen im Bereich **Wange / unter dem Auge**
- **Druckschmerz + Ausstrahlung**
- **Nasenatmungsbehinderung einseitig**
- **Schwellung im Gesicht**
- Verschlechterung nach initialem „Erkältungsverlauf“
- kaum Ansprechen auf Analgetika
- bekannte **Nasenpolypen**

👉 Wichtig:
→ wegen **Augendruck + möglicher Sehbeeinträchtigung**
➡️ **komplizierter Verlauf (orbital!) muss ausgeschlossen werden**

⚠️ Wichtige Differenzialdiagnosen (DD)

1. Orbitalphlegmone / Orbitakomplikation

- gefährliche Komplikation der Sinusitis

Hinweise im Fall:

- Druck hinter dem Auge
- mögliche Sehverschlechterung
- Gesichtsschwellung

👉 **Notfall → sofortige Abklärung (CT + Augenarzt)**

---

2. Dentogene Sinusitis

- Ursprung von Zahnwurzelentzündung (Oberkiefer)

Dafür spricht:

- Lokalisation: **Oberkiefer / Wange**
- einseitig

👉 Immer Zahnstatus prüfen!

---

3. Trigeminusneuralgie

Dagegen spricht:

- Schmerz ist **dauerhaft**, nicht einschießend
- eher **dumpf/drückend**, nicht elektrisierend

👉 daher unwahrscheinlich

---

4. Migräne (atypisch)

Dagegen spricht:

- klare **einseitige Nasensymptomatik**
- **Schwellung + Druckschmerz**
- kein typischer Verlauf (keine Attacken)

---

5. Cluster-Kopfschmerz

Dagegen spricht:

- keine Attacken, sondern **Dauerschmerz**
- keine typischen autonomen Symptome (Tränenfluss etc.)

---

6. Tumor im Nasennebenhöhlenbereich

(z. B. Sinus maxillaris)

Red Flags:

- einseitige Beschwerden
- Schwellung
- progredient
- bekannte Polypen

👉 aktuell weniger wahrscheinlich, aber:
➡️ **bei fehlender Besserung unbedingt ausschließen**

---

7. Chronische Rhinosinusitis mit Exazerbation

- sehr wahrscheinlich als **Grundlage**